

AHIを用いて分類されており、米国睡眠医学会（AASM）では $5 \leq \text{AHI} < 15$ を軽症、 $15 \leq \text{AHI} < 30$ を中等症、 $\text{AHI} \geq 30$ を重症と分類している。

PSGは入院のうえ、専用の検査室において脳波も測定して行う検査であるため、どの施設でも行えるわけではない。一方、一般的に簡易型モニターは脳波測定を行わないため在宅でも施行可能であるが、睡眠1時間あたりの指数であるAHIを算出することはできない。そのため、職域や一般の医療機関でのスクリーニングに適している。簡易型モニターでは、検査時間1時間あたりの呼吸イベント数（Respiratory event index: REI）が重症度指標となる。

治療

標準的治療はnasal continuous positive airway pressure（CPAP）である。CPAPは、OSAS治療の第一選択として有効性、安全性とも確立されているが、あくまで対症療法であり、また、毎晩装置を装着して就寝しなくてはならないなどの煩わしさがある。しかし、図2に示したように、重症患者の死亡率を健常者と同等にまで引き下げており、極めて有効な治療法である。本邦でのCPAPの健康保険適用基準は、PSG上、 $\text{AHI} \geq 20$ 、簡易型モニター上、 $\text{REI} \geq 40$ となっている。

近年は、機器自体が上気道の閉鎖状況をセンシングしながら圧調整を自動で行うAuto-CPAPが繁用されるようになり、患者にとってさらに使いやすくなっている。しかしながら、いまだCPAPのアドヒアランスは決して満足できるものではない。2018年に保険収載された遠隔モニタリング加算はアドヒアラン

スの改善が期待されるものである。医療者はクラウド上のデータサーバーに転送されたCPAP使用状況などのデータを閲覧し患者に指導を行うことができるようになった。

CPAP以外の治療で、有効性が認められているのは口腔内装置（oral appliance: OA）である。これは、一種のマウスピースで、就寝時にこれを装着することにより下顎を前方に移動させ、上気道の拡大を図る装置である。また、最近注目されている植込み型舌下神経電気刺激療法はCPAPに忍容性を示さない患者に対する新規治療である。本邦においても2021年に保険収載され実臨床で導入が可能となっており、日本循環器学会を中心に作成された「2023年改訂版循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン」にも推奨レベルとともに記載されている治療である⁶⁾。

減量は、肥満がある患者にはすべて考慮されるべき治療法であるが、現実には、減量だけでOSASを治療するのは困難である。軽症例では、側臥位睡眠指導や、アルコール、睡眠薬の服用を止めるなどの生活習慣を変えるだけで改善することもある。

文献

- 1) Marin JM, et al : Lancet 365 : 1046, 2005
- 2) Young T, et al : N Eng J Med 328 : 1230, 1993
- 3) Peppard PE, et al : Am J Epidemiol 177 : 1006, 2013
- 4) 睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドライン 2020
- 5) Benjafield AV, et al : Respir Med 7 : 687, 2019
- 6) 2023年改訂版循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン